Hjelp! Petter må bestå helsefag eksamen!!

Han trenger ekstra cash til en skikkelig klokke!!

HEA3103 Vår 2024

Oppgave 1 ca. 50 %, 2a ca. 30 %, 2b ca. 20 %

Case / situasjon

Sted: Hjemmesykepleien

Pasient: Per Larsen, f. 21.08.1945, ugift. Pårørende: bror i Oslo. Bor i Bergen.

Diagnoser: Hjertesvikt etter hjerteinfarkt i 2021.

Medisiner: Betablokkere, blodfortynnende, kolesterolsenkende.

Arbeidsoppdrag:

- Ca. kl. 09: hjelp til støttestrømper + veiledning/tilrettelegging frokost og lunsj.
- Ca. kl. 13: gå tur sammen med Per.

Fra pasientjournal:

- Hygiene: klarer selv.
- Sirkulasjon: trenger hjelp til støttestrømper.
- Ernæring: overvektig, glad i sjokolade, lite motivert for å lage mat.
- Psykososialt: deprimert, lite motivert for aktivitet, ensom, lite nettverk.
- Fysisk: lite aktiv. Bruker rullator.
- Samarbeid: fastlege, fysioterapeut, hjemmehjelp hver 3. uke.

Oppgaver og eksempelsvar

Oppgave 1

Oppgavetekst: Ta utgangspunkt i situasjonsbeskrivelsen, pasientjournalen og arbeidsoppdrag 1. Lag en tiltaksplan for Per. Beskriv hva du vil gjøre, hvordan du vil gjøre det, og hvorfor du velger å gjøre det slik.

Eksempelsvar

Innledning

Denne tiltaksplanen gjelder arbeidsoppdrag 1 hos Per Larsen i hjemmesykepleien i Bergen, ca. kl. 09. Jeg skal hjelpe ham med støttestrømper og veilede og tilrettelegge for frokost og lunsj. Per har hjertesvikt etter et hjerteinfarkt i 2021 og bruker betablokkere, blodfortynnende og kolesterolsenkende medisiner. Han er overvektig, glad i sjokolade og lite motivert for å lage mat. Han er også deprimert, ensom og lite aktiv. Målet er

at Per får støttestrømpene riktig på, at han spiser et sunnere måltid som han selv har vært med å velge, og at jeg følger med på tegn til forverring.

Hoveddel

Når jeg kommer, hilser jeg og forteller kort hva vi skal gjøre. Jeg spør hvordan natten har vært og hvordan han har det i dag. Det viser respekt for at jeg er i hjemmet hans, og det gir meg samtidig viktige opplysninger. Ved hjertesvikt er det viktig å legge merke til om han er mer tungpustet enn vanlig, om han har sovet dårlig fordi han ikke får puste når han ligger flatt, og om bena er mer hovne.

Før jeg tar på støttestrømpene, ser jeg på bena. Jeg observerer hevelse, hudfarge, tørr hud og sår. Hvis hevelsen er tydelig økt eller jeg ser sår, melder jeg det til sykepleier før strømpene tas på, fordi det kan være tegn på at hjertesvikten forverres. Jeg bruker riktig teknikk eller påtrekkshjelpemiddel og sørger for at strømpene sitter glatt uten folder. Støttestrømper hjelper blodet tilbake fra bena og kan redusere hevelse, men folder kan gi trykk og sår, og huden til eldre er skjør. Blodfortynnende medisin gjør også at blåmerker og sår kan bli større.

Deretter snakker vi om frokost og lunsj. Jeg spør hva Per liker og hva han har i huset. Jeg foreslår enkle valg som grovt brød, magert pålegg, egg, fisk og frukt eller grønnsaker, og jeg kan smøre lunsjen sammen med ham og sette den i kjøleskapet. Jeg forteller kort at mindre salt og mettet fett er bra for hjertet, og at det å spise jevnlig kan gjøre det lettere å la sjokoladen ligge. Jeg moraliserer ikke og forbyr ikke sjokolade, men vi kan bli enige om at den kan være en kos på et fast tidspunkt. Når Per er med å bestemme, er sjansen større for at han følger rådene. Det er også medvirkning slik pasient- og brukerrettighetsloven beskriver.

Per er deprimert og ensom, og det påvirker både matlyst og egenomsorg. Derfor tar jeg meg tid til en kort samtale mens vi lager maten. Kanskje kan vi snakke om turen vi skal gå kl. 13, slik at han har noe å se fram til.

Til slutt dokumenterer jeg tilstanden på bena, hvordan han har det, hva han spiste og hva vi ble enige om. Endringer som økt hevelse, tungpust eller tegn på at han ikke tar medisinene, melder jeg til sykepleier. Helsepersonelloven krever at jeg dokumenterer, og det er sykepleier og fastlege som vurderer behandlingen.

Jeg evaluerer ved å se om strømpene sitter godt og ikke gir sår, om Per spiste maten vi lagde, og om han virket mer positiv. Over tid kan vekt og hevelse si noe om tiltakene virker.

Avslutning

Tiltaksplanen bygger på Pers diagnose og journal. Den kombinerer praktisk hjelp med støttestrømper, observasjon av tegn på forverret hjertesvikt, kostveiledning der Per er med å bestemme, og oppmerksomhet på at han er deprimert og ensom. Jeg holder meg innenfor det helsefagarbeideren skal gjøre, og jeg samarbeider med sykepleier og fastlege.

Oppgave 2a

Oppgavetekst: Ta utgangspunkt i situasjonsbeskrivelsen, pasientjournalen og arbeidsoppdrag 2. Lag en tiltaksplan med faglige begrunnelser for arbeidsoppdrag 2. Målet er å fremme livskvalitet og mestring.

Eksempelsvar

Innledning

Arbeidsoppdrag 2 er å gå tur med Per ca. kl. 13. Per har hjertesvikt, bruker rullator og er lite aktiv. Han er også deprimert, ensom og har lite nettverk. Målet med tiltaksplanen er å fremme livskvalitet og mestring. Turen skal være trygg for hjertet, og den skal være noe Per opplever som positivt, slik at han får lyst til å gå igjen.

Hoveddel

Jeg planlegger turen sammen med Per. Jeg spør hvor han liker å gå, og vi avtaler en kort og flat rute med steder der han kan hvile, for eksempel en benk. Vi kan gjerne gå til et sted han har et forhold til. Jeg sjekker at rullatoren er i orden, at han har gode sko og klær etter været, og at han har drukket og spist. Når Per er med å bestemme, får han eierskap til turen. Det øker motivasjonen hos en som ellers har lite lyst til aktivitet.

Før vi går, spør jeg hvordan han har det, og jeg ser etter tungpust eller hevelse i bena. Hvis han er tydelig dårligere enn vanlig, utsetter jeg turen og melder fra til sykepleier. Under turen går jeg ved siden av ham i hans tempo. En god regel er at han skal klare å snakke mens han går. Jeg observerer pust, hudfarge, svette og om han blir sliten eller svimmel, og vi tar pause før han blir utmattet. Ved hjertesvikt tåler hjertet lett aktivitet, og det kan gi bedre kondisjon, søvn og humør, men for mye belastning kan være farlig. Betablokkere gjør at pulsen ikke alltid stiger slik vi forventer, så jeg ser mer på hvordan han puster og har det.

Turen er også et sosialt tiltak. Jeg prater med Per om ting han er opptatt av, og jeg gir ham ros for det han klarer, for eksempel at han gikk litt lenger enn sist. Han er ensom, og en hyggelig samtale kan bety like mye for livskvaliteten som selve gangen. Fysisk aktivitet kan også dempe depressive plager. Hvis han har lyst, kan vi snakke om andre muligheter for å komme seg ut, som et dagsenter eller en turgruppe. Det vil i så fall være noe jeg tar opp med sykepleier.

Etter turen spør jeg hvordan han opplevde den, og jeg ser at han hviler og får drikke. Jeg dokumenterer hvor langt og lenge vi gikk, hva jeg observerte og hva Per selv sa. Dokumentasjonen gjør at fysioterapeuten og kollegene kan bygge videre, og at turene kan økes gradvis hvis det går bra.

Jeg evaluerer ved å se om Per klarte turen uten tegn til forverring, og om han sier at han vil gå igjen. Over flere uker kan vi se om han orker mer, og om humøret blir bedre.

Avslutning

Tiltaksplanen kobler fysisk aktivitet til Pers psykiske og sosiale behov. Han er med å planlegge, turen er tilpasset hjertesvikten, og jeg observerer ham hele tiden. Slik kan turen gi både mestring og livskvalitet uten å sette helsen hans i fare.

Oppgave 2b

Oppgavetekst: Per og du går tur. Du observerer etter hvert at han går saktere, blir mer stille og er blek. Per sier han føler seg svimmel. Han greier ikke å stå på bena lenger. Beskriv hva du gjør, og begrunn valgene dine faglig.

Eksempelsvar

Innledning

Under turen endrer Pers tilstand seg. Han går saktere, blir stille og blek, sier at han er svimmel, og til slutt klarer han ikke å stå. Per har hjertesvikt etter hjerteinfarkt og bruker blodfortynnende medisin. Dette kan være en akutt og alvorlig situasjon, og jeg må handle raskt, rolig og forsvarlig.

Hoveddel

Det første jeg gjør, er å stoppe turen og hindre at han faller. Jeg støtter ham og hjelper ham ned, helst på rullatorsetet, en benk eller bakken. Et fall kan gi brudd eller hodeskade, og fordi han bruker blodfortynnende, er det større fare for blødning. Hvis han føler seg svimmel og blek, kan det hjelpe å legge ham ned og eventuelt heve bena, så lenge han ikke blir mer tungpustet av det. Hvis han får tungt for å puste, er det bedre at han sitter.

Deretter vurderer jeg ham raskt. Jeg sjekker om han er våken og svarer, om han puster normalt, og om huden er kald og klam. Jeg spør om han har smerter i brystet, armen eller kjeven, om han er kvalm eller tungpustet. Brystsmerter, kald svette og tungpust kan være tegn på nytt hjerteinfarkt. Svimmelhet og blekhet kan også skyldes lavt blodtrykk eller forstyrrelser i hjerterytmen, som Per har økt risiko for.

Fordi symptomene er alvorlige og han ikke klarer å stå, ringer jeg 113. Jeg sier hvor vi er, hva som har skjedd og hva jeg observerer, og jeg følger rådene fra operatøren. Jeg blir hos Per hele tiden, snakker rolig til ham og holder ham varm. Hvis han slutter å puste normalt, starter jeg hjerte-lunge-redning etter det jeg har lært. Så snart det er mulig, varsler jeg sykepleier i hjemmesykepleien, slik at de vet hva som skjer og kan varsle videre.

Jeg skal ikke prøve å få Per hjem selv, og jeg skal ikke vente for å se om det går over. Som helsefagarbeider er det ikke min oppgave å stille diagnose, men jeg skal kjenne igjen tegn på at noe er alvorlig og sørge for at riktig hjelp kommer fort. Helsepersonelloven krever at jeg gir forsvarlig hjelp og øyeblikkelig hjelp når det er nødvendig.

Etterpå dokumenterer jeg tidspunkt, hva jeg observerte, hva jeg gjorde og hvem jeg varslet. Det er viktig for videre behandling og for å lære av hendelsen. Jeg kan også tenke gjennom om turen var for lang, og om aktivitetene må vurderes på nytt sammen med sykepleier og fastlege.

Avslutning

I denne situasjonen er det viktigste å forhindre fall, observere tegn på alvorlig sykdom, ringe 113 og bli hos Per. Jeg handler raskt fordi han har kjent hjertesykdom, og fordi symptomene kan være tegn på et nytt infarkt eller annen akutt svikt.

Eksempelsvar til øving, skrevet med sikte på et nivå mellom karakter 4 og 5. Uoffisielt – ikke en karaktergaranti eller offisielt fasitsvar.